

低频康复治疗仪对产妇产后子宫复旧及乳房胀痛的影响

杨 柳, 谢翠云, 钟 豫, 覃雪英

(广西壮族自治区梧州市中医医院 妇产科, 广西 梧州, 543000)

关键词: 低频康复治疗仪; 产妇; 子宫复旧; 乳房康复

中图分类号: R 714.63 文献标志码: A 文章编号: 1672-2353(2017)08-224-02 DOI: 10.7619/jcmp.201708075

研究^[1]显示,子宫复旧不全和母乳喂养率低是产妇最常见的健康问题。低频脉冲治疗仪是一种康复治疗设备,主要是通过蜗形磁场穿透至深层组织,带动局部组织运动,缓解组织张力,利用毛细血管收缩与血液循环,激活细胞,调整加速腺体分泌,使产妇能够接受更长久和更深入的治疗^[2]。本院2015年6—12月对75例产妇开展了低频康复治疗仪护理,取得较好的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择150例顺利分娩的产妇。纳入标准:①年龄18~35岁的单胎初产妇;②所有产妇自愿接受治疗;③无严重的心肺障碍和精神疾病;④产妇孕周均在37~40周;⑤新生儿各项指标均正常。排除标准:①患有严重的心肺障碍和精神类疾病;②产后有严重的并发症;③有引产、早产等历史;④多胎产妇;⑤胎儿指标有异常。将所有患者分为2组。观察组产妇年龄为20~34岁,平均 (29.6 ± 5.1) 岁;妊娠时间为 (38.6 ± 1.6) 周;体质量为68~79 kg,平均 (71.1 ± 10.7) kg;34例为剖宫产,41例为引导分娩;新生儿体质量为2.31~4.47 kg,平均 (3.12 ± 1.66) kg。对照组产妇年龄为22~35岁,平均 (29.9 ± 5.3) 岁;妊娠时间为 (38.7 ± 1.7) 周;体质量为69~78 kg,平均 (71.3 ± 10.5) kg;31例为剖宫产,44例为引导分娩;新生儿体质量为2.33~4.48 kg,平均 (3.14 ± 1.68) kg。2组产妇一般资料比较,差异无统计学意义($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组产妇为常规护理,观察组产妇则使用低频康复治疗仪进行护理治疗。

观察组产妇不仅需要进行常规的产后康复和新生儿护理指导,还需要在此基础上采用低频脉冲康复治疗仪进行治疗。产妇分娩结束后的2 h开始治疗,若是剖宫产患者需要在生命特征稳定之后开展治疗。在使用低频脉冲康复治疗仪之前需要由专门的人员对其功效、作用、目的和方法以及治疗过程中需要注意的事项进行讲解,提高产妇的治疗依从性。具体如下:产妇需要保持平卧位,在使用前用毛巾(温度控制在 $40 \sim 45^{\circ}\text{C}$)对产妇的乳房进行湿敷,时间为 $10 \sim 15$ min^[3]。对局部的皮肤进行常规的清洁和消毒之后,需要将耦合剂涂在专门的电极上,使用固定带将其固定好,进行催乳和子宫复旧治疗,让产妇的皮肤和电极片充分的接触^[4]。按下开始键,按照之前已经设定好的程序进行治疗。刺激程度可以从低到高依次提升,根据产妇自身的情况将其调整在合理范围之内。每次需要接受30 min的治疗,治疗过程中确保外部环境的安静,实时观察产妇是否有头晕、胸闷等不良反应出现,如果产妇出现不良反应而且不断加重需要及时停止。每天治疗1次,共3 d。

1.3 观察指标

本研究设定的观察指标分别为泌乳量、子宫的复旧程度、乳房舒适度、母乳喂养成功率。泌乳量指标:分为少、正常和充足,婴儿吃奶后安静入睡,精神愉快,产妇挤压时有乳汁而且乳房胀满,婴儿大便2~3次/d,黄色成形^[5]。子宫复旧程度标准:用排气时间、排尿时间、宫缩痛持续时间、产后24 h阴道出血量等指标进行判定。乳房舒适度指标:按照世界卫生组织设置的标准为准,将舒适度分为4个等级:无痛感为0级;轻度疼痛,未对产妇休息产生影响为1级;疼痛影响产妇休息但是在其可忍受范围之内为2级;产妇无法入

收稿日期: 2017-01-03

基金项目: 广西壮族自治区卫计委青年项目(20164Y01222)

睡,疼痛难耐为3级,舒适度在产后1~3 d进行统计和评定。母乳喂养成功率评判标准:采用Matthews测量工具对产妇第一次母乳喂养的情况进行调查。包含4个方面的指标:喂养婴儿的状态、婴儿吮吸情况、喂养婴儿时的姿势和母婴接触时的表现,每个维度4个条目,总分12分,喂养成功标准为大于8分。

2 结 果

观察组患者的排气时间、排尿时间、宫底高度和宫缩痛时间等显著短于对照组($P < 0.05$),见表1。2组乳腺炎发生率、泌乳量和乳房胀痛程度等指标比较,差异有统计学意义($P < 0.05$)。见表2。

表1 2组产妇产后子宫复旧情况比较

子宫复旧情况	观察组($n=50$)	对照组($n=50$)
宫缩痛时间/h	$2.19 \pm 0.24^*$	2.87 ± 0.55
阴道出血量/mL	$91.54 \pm 57.99^*$	103.27 ± 68.47
宫底高度/cm	$10.51 \pm 2.20^*$	12.46 ± 3.69
恶露时间/d	$10.44 \pm 2.37^*$	19.46 ± 5.33
排尿时间/h	$4.50 \pm 30.79^*$	5.35 ± 1.23
排气时间/h	$12.91 \pm 50.14^*$	14.71 ± 53.11

与对照组比较, * $P < 0.05$ 。

表2 2组产妇乳房复旧情况比较 [n(%)]

乳房复旧情况	观察组($n=50$)	对照组($n=50$)
泌乳量		
充足	21(28.0)*	8(10.7)
正常	24(32.0)*	17(22.7)
少	30(40.0)*	50(66.7)
母乳喂养成功率	68(90.7)*	56(74.7)
乳房胀痛		
0 + I	60(80.0)*	45(60.0)
II + III	15(20.0)*	30(40.0)
乳腺炎	3(4.0)*	10(13.3)

与对照组比较, * $P < 0.05$ 。

3 讨 论

有研究^[6-7]报道,低频脉冲治疗仪在加速子宫复旧、减少产后出血及产后尿潴留等方面都有明显效果。本研究中,观察组产妇使用低频脉冲康复治疗仪治疗,恶露时间、排尿时间及排气时间短,产后24 h的阴道出血量少、产后3 d的子宫底高度低。这一方面由于子宫与乳房具有相关性,低频脉冲康复治疗仪在催乳同时加快子宫收缩,促进恶露的排出,有利于子宫的收缩。另一方面低频脉冲治疗仪可以将电磁波投射到更深层的组织当中,对产妇的穴位形成直接的刺激和揉搓,使人体功能状态得到更好的调节^[8]。有研究^[9]显示,康复治疗仪可通过局部刺激子宫,使产妇松弛

的盆腔肌产生收缩运动,快速加强产妇的盆底肌肌肉张力,恢复筋膜张度,从而使子宫得到康复。除此之外,低频脉冲康复治疗仪还可以使盆腔筋膜和肌肉进行更加规律的运动,带动膀胱肌和子宫韧带进行规律运动,使盆腔的淤血不断消失,加快恶露的排出速度^[10]。低频康复治疗仪还能解除膀胱肌麻痹,使膀胱及尿道支持组织力量加强,使膀胱内压力不同程度的增大,帮助产妇恢复产后自主排尿,降低产后尿潴留的发生率^[11]。有研究^[12]显示低频脉冲刺激使平滑肌筋膜松弛,减少疼痛,促进肠蠕动,促进排气。

低频脉冲治疗仪对乳房胀痛所产生的影响主要表现在它可以使产妇的乳腺管被疏通,促进产后早期泌乳^[13]。本研究中,采用低频脉冲康复治疗仪治疗的观察组患者不仅能够实现产后泌乳,而且也使母乳喂养的成功率大大提高,减少乳腺炎和乳房胀痛现象的发生。

参考文献

- [1] 朱洁华. 缩宫催乳汤联合产后康复治疗仪促进产后康复的效果观察 [J]. 现代中西医结合杂志, 2013, 22(8): 853-855.
- [2] 姜小环, 林艳娟. 产后康复综合治疗仪配合护理干预治疗产后尿潴留的临床研究 [J]. 中国基层医药, 2014, 21(4): 632-633.
- [3] 唐芳. 护理干预对降低产后并发症的应用效果 [J]. 北方药学, 2013, 10(9): 178-180.
- [4] 徐嘉, 朱文英, 徐峰, 等. 早期应用产后康复治疗仪促进产褥期妇女康复的效果 [J]. 护理实践与研究, 2014, 11(3): 43-44.
- [5] 丰有吉. 妇产科学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 402-406.
- [6] 刘芬琴, 吴雪文, 郑敏亚, 等. 产后康复治疗仪对产妇康复的效果评价 [J]. 浙江预防医学, 2014, 26(6): 620-621.
- [7] 陈玉清, 裴慧慧, 陈蓓, 等. 盆底康复训练对改善产后盆底肌功能的作用 [J]. 中国康复医学杂志, 2013, 28(3): 234-238.
- [8] 李日清, 施月秋. 产后康复治疗延伸服务对产褥期产妇产后康复的效果观察 [J]. 护士进修杂志, 2011, 10(21): 121-122.
- [9] 周春燕. 低频脉冲电治疗在产后恢复中的应用 [J]. 中国医药指南, 2014, 12(19): 165-166.
- [10] 何妙文, 张珂. 妇产康复治疗仪对产妇产后子宫修复、泌乳及新生儿预后的影响 [J]. 中国现代医生, 2015, 53(10): 44-45, 49.
- [11] 曹付梅, 袁静, 李桂芬. 产妇产后早期应用低频脉冲治疗仪的疗效观察 [J]. 全科护理, 2014, 12(19): 175-177.
- [12] 苟元, 张俊茹, 张维娜, 等. 低频脉冲催乳治疗对产妇产后恢复的影响 [J]. 贵阳中医学院学报, 2012, 34(5): 65-66.
- [13] 王国芬, 包春就, 李春花, 等. 妇科综合治疗仪对产妇产后康复效果观察 [J]. 中国临床新医学, 2011, 04(10): 926-928.